

SÍNCOPE

Manuela Montes Montes, Laura Alvarez Roy.

INTRODUCCIÓN

El síncope es un síndrome clínico que se define como una pérdida de conciencia, transitoria, con pérdida del tono muscular y recuperación completa, espontánea y generalmente rápida.

El mecanismo que subyace es una hipoperfusión cerebral global transitoria (sólo deben considerarse síncope las pérdidas de conciencia consecuencia de este mecanismo).

Supone alrededor del 1% de los pacientes atendidos en los servicios de urgencias, con un porcentaje de ingreso en torno al 40%.

El síncope debe ser diferenciado de otras formas “no sincopales” asociadas con real o aparente pérdida transitoria de conciencia.

Pérdidas transitorias de conciencia	Alteración del nivel de conciencia
• Crisis epiléptica • Ictus vertebrobasilares o accidente isquémico transitorio carotídeo • Intoxicaciones • Trastornos metabólicos como hipoglucemia	• Caídas • Drop attacks • Cataplejía

DIAGNÓSTICO

Evaluación inicial

El inicio de la evaluación de síncope es una cuidadosa anamnesis, examen físico y ECG. Esta evaluación inicial puede definir la causa del síncope en un 23-50% de los pacientes.

Anamnesis

Se deben recoger los siguientes aspectos en la historia clínica:

- **Antecedentes:** Historia familiar de muerte súbita o cardiopatía. Enfermedad cardíaca previa. Historia neurológica (Epilepsia, narcolepsia, Parkinson). Trastornos metabólicos (diabetes.). Medicación (antihipertensiva, antianginosa, antidepresiva, antiarrítmica, diurética, fármacos que prolongan el QT). Alcohol. Recurrencias, como el tiempo transcurrido desde el primer episodio sincopal y el número.
- **Circunstancias antes del evento:** Posición (en decúbito supino, sentado o de pie). Actividad (descanso, cambio de postura, durante o después del ejercicio, durante o inmediatamente después de la micción, defecación, tos o deglución). Factores predisponentes (lugares abarrotados o con calor, estar de pie durante un tiempo prolongado, periodo posprandial) y episodios precipitantes (miedo, dolor intenso, movimientos del cuello).
- **Comienzo del evento:** Brusco o precedido de pródromos (náuseas, vómitos, sudoración, aura, dolor en cuello, visión borrosa, mareo) u otra clínica como palpitaciones o dolor torácico.
- **Evento (testigo presencial):** forma de caer, duración, forma de respirar, movimientos (tónicos, clónicos, tonico-clónicos, automatismo, morderse la lengua).
- **Finalización del evento:** náuseas, vómitos, sudoración, sensación de frío, confusión, color de la piel, lesión, dolor torácico, palpitaciones, incontinencia urinaria o fecal.

Exploración física

- **Inspección general:** nivel de conciencia, hidratación, coloración.
- **Constantes:** frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Tensión arterial en supino y tras sedestación-bipedestación.
- **Exploración:** auscultación cardíaca, pulmonar y de carótidas. Palpación de pulsos.
- **Exploración neurológica:** si hay dudas sobre si se trata de un episodio sincopal.

Pruebas complementarias

ECG: un electrocardiograma de 12 derivaciones debe ser realizado a todos los pacientes con síncope. Lo más frecuente es que sea normal, lo que supone un bajo riesgo de síncope de origen cardíaco. Un ECG anormal es un predictor independiente de causa cardíaca o alta mortalidad.

Analítica sanguínea:

- **Hemograma.**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, amilasa, bilirrubina, PCR, procalcitonina, lactato CK, CKmb, troponina I o ultrasensible dependiendo del nivel asistencial. Hormonas tiroideas . Se solicitará para descartar alteraciones electrolíticas, anemia, cuadros sépticos, marcadores de daño miocárdico.
- **Coagulación:** se solicitará Dímero D si sospecha de TEP.
- **Sistemático y sedimento de orina.** Si sospechamos ingesta de sustancias tóxicas, realizar **tóxicos en orina** (debemos de pedir consentimiento escrito u oral al paciente/familiares, reflejarlo en la historia clínica)

Pruebas de imagen

- **Radiografía de tórax AP-Lateral.** Para la valoración de cardiopatía estructural y causas secundarias de síncope, si inestabilidad del paciente la radiografía será realizada en el box del paciente.
- **TC cráneo:** si clínica de focalidad neurológica, ICTUS o hemorragia subaracnoide (si la clínica es sugestiva de hemorragia subaracnoidea y la TC de cráneo es normal, debemos de realizar punción lumbar).
- **Angio-TC:** si se sospechamos TEP o disección aórtica.
- **Ecocardiograma:** frecuentemente usado en el síncope, pero su sensibilidad es baja en ausencia de hallazgos clínicos, físicos y ECG sugerentes de enfermedad cardíaca. Nos ayuda a determinar la causa de síncope si hallamos una enfermedad cardiaca moderada o severa (por ejemplo, estenosis aórtica severa, tumores cardíacos, aneurismas y trombos en aurícula), si la enfermedad es leve la probabilidad de causa cardíaca es baja.

Masaje del seno carotídeo

Ejercer presión en el lugar donde la arteria carótida común se bifurca produce un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca y una caída de la tensión arterial. La exageración de este fenómeno se denomina hipersensibilidad del seno carotídeo. Está indicado realizarlo en pacientes mayores de 40 años con síncope de etiología desconocida después de la evaluación inicial, de forma secuencial en el lado derecho e izquierdo durante 10 segundos, bajo monitorización continua de frecuencia cardíaca y tensión arterial. Es diagnóstico cuando se reproduce el síncope en presencia de una asistolia mayor de 6 segundos y/o caída de la presión arterial mayor de 50 mmHg.

CLASIFICACIÓN

Los resultados de la evaluación inicial son diagnósticos de síncope en las siguientes situaciones:

Síncope neuromediado (síncopes reflejos)

Referido a reflejos que cuando se desencadenan producen vasodilatación y bradicardia. Lo que distingue unos tipos de síncope de otros, es el estímulo desencadenante.

- **Síncope vasovagal:** existe un estímulo precipitante como miedo, dolor intenso, estrés emocional, permanecer tiempo de pie, asociados con síntomas prodrómicos típicos (náuseas, malestar abdominal, palidez, sudoración, debilidad muscular...) y posterior pérdida de conciencia y con recuperación paulatina. Tras la recuperación el paciente permanece hipotenso y la incorporación puede dar lugar a nuevos episodios. Es la causa más común de síncope y suele iniciarse en edades jóvenes.
- **Síncope situacional:** después o durante la micción, defecación, toser o tragar.
- **Síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo:** considerar en pacientes con síncope por collares apretados, afeitado, giro de cabeza...Se comprueba una respuesta diagnóstica en el masaje del seno carotídeo.

Síncope ortostático

Descenso brusco de la tensión arterial al adoptar la posición de bipedestación debido a hipovolemia o un fallo de los mecanismos reflejos que controlan la tensión arterial. La medida de la tensión arterial se recomienda tras 5 minutos de estar en posición supina, durante 3 minutos en bipedestación, una bajada de tensión arterial sistólica mayor o igual a 20 mmHg o una tensión arterial sistólica menor de 90 mmHg, define la hipotensión ortostática como causa de síncope.

Síncope cardiogénico

Suponen el 10-40% de los síncope. Suelen ser de instauración muy brusca, de corta duración y la recuperación suele ser muy rápida. Si son suficientemente prolongados pueden aparecer signos de anoxia cerebral severa (convulsiones, incontinencia de esfínteres). Puede ser:

1. Síncope arrítmico: Arritmia como causa primaria del síncope, en la evaluación inicial el ECG nos permite realizar este diagnóstico ante la presencia:

- Bradicardia sinusal persistente < 40 lpm en vigilia o bloqueo sinoauricular repetitivo o pausas sinusales > o igual a 3 segundos.
- Bloqueo auriculoventricular de segundo grado Mobitz II o de tercer grado.
- Bloqueo alternante de rama izquierda y derecha.
- Taquicardia ventricular o supraventricular paroxística rápida.
- Episodios no sostenidos de taquicardia ventricular polimórfica e intervalo QT largo o corto.
- Disfunción de marcapasos.

En otras ocasiones el ECG nos permite sospechar el posible origen arrítmico del síncope:

- Bloqueo bifascicular (de rama derecha o izquierda combinada con bloqueo fascicular anterior izquierdo o posterior izquierdo) u otras anomalías de la conducción intraventricular con duración del QRS > o igual a 120 ms.
- Bradicardia sinusal inadecuada asintomática (< 50 lpm).
- Complejos QRS preexcitados.
- Intervalo QT prolongado o corto.
- Patrón de bloqueo de rama derecha con elevación del segmento ST en las derivaciones V1-V3 (patrón de Brugada).
- Patrón compatible con miocardiopatía arritmogénica ventricular derecha.

2. Síncope secundario a isquemia: si los síntomas están presentes con un ECG de isquemia

aguda con o sin IAM. Típicamente de infartos inferiores, ya sea por presencia de bloqueo completo secundario a isquemia del nodo aurículo-ventricular; o por hipotensión, en afectación del ventrículo derecho.

3. Síncope secundario a cardiopatía estructural o enfermedad cardiopulmonar: Se diagnostican mediante las diferentes pruebas complementarias (ecocardiograma, TAC), como por ejemplo estenosis aórtica severa, mixoma auricular, enfermedad pericárdica/taponamiento, disección de aorta, embolismo pulmonar/hipertensión pulmonar.

Otros tipos de síncope

- **Síncope de esfuerzo:** Durante o inmediatamente después del ejercicio. Sugestivo de origen cardiológico.
- **Síncope secundario a fármacos:** algunos fármacos pueden ser causa de síncope al provocar hipotensión (hipotensores, diuréticos, vasodilatadores...) o al inducir arritmias (efecto proarrítmico de algunos antiarrítmicos). La cocaína y cannabis también pueden ser causa de síncope.
- **Síncope secundario a enfermedad neurológica:** muchas enfermedades neurológicas pueden causar hipotensión ortostática e inducir síncope.

TRATAMIENTO

SÍNCOPE NEUROMEDIADO: Recomendaciones. Valorar la contribución de la cardioinhibición y vasopresión porque hay estrategias diferentes para los dos aspectos.

- Explicación del riesgo y pronóstico. Mención especial a los pacientes de alto riesgo ocupacional.
- Evitar factores y situaciones desencadenantes del síncope.
- Modificar o retirar drogas hipotensoras.
- Expansión de volumen con suplementos de sal, programas de ejercicio.
- Estimulación cardíaca en pacientes con síndrome del seno carotídeo mixto o cardioinhibidor o síncope vasovagal cardioinhibidor con más de 5 episodios/año o daño físico severo y edad mayor de 40 años.

SÍNCOPE ORTOSTÁTICO: El tratamiento depende de la causa que lo condicione. Se pueden dar fármacos para aumentar la retención de sodio, drogas vasoactivas para aumentar las resistencias.

SÍNCOPE CARDIOGENICO: Debe recibir el tratamiento apropiado a la causa.

Estratificación del riesgo

Si tras la evaluación inicial no se consigue determinar la causa del síncope, se debe evaluar el riesgo, atendiendo especialmente a dos circunstancias:

- Riesgo de muerte súbita.
- Riesgo de síncope recurrente con traumatismo asociado.

Criterios De Alto Riesgo Del Paciente Con Síncope

- Enfermedad arterial coronaria.
- Enfermedad estructural severa (insuficiencia cardíaca, FEVI bajo o IAM previo).

Características Clínicas Que Indiquen Síncope Arrítmico

- Síncope durante el esfuerzo o en decúbito supino, palpitaciones, historia familiar de muerte

súbita.

- Características del ECG que indiquen o sugieran síncope arritmico.
- Anemia grave.
- Desequilibrios electrolíticos graves.

Criterios de hospitalización.

Para el diagnóstico

- Sospecha o causa conocida de enfermedad cardíaca.
- Alteraciones ECG sospechosas de síncope arritmogénico.
- Síncope durante el ejercicio.
- Síncope con traumatismo severo.
- Historia familiar de muerte súbita.

Para el tratamiento

- Síncope por arritmias cardíacas.
- Síncopes debidos a isquemia miocárdica.
- Síncope 2º a enfermedad cardíaca estructural o cardiopulmonar.
- Ictus o presencia de focalidad neurológica.
- Síncope con indicación de marcapaso.

BIBLIOGRAFÍA

- Moya A, Sutton R, Ammirati F, Blanc JJ, Brignole M, Dahm JB et al. Guía de práctica clínica para el diagnóstico y manejo del síncope. Rev Esp Cardiol. 2009;62(12): 1466.e1-e52.
- Moya-I-Mitjans A, Rivas-Gándara N, Sarrias-Mercè A, Pérez-Rodón J, Roca-Luque I. Puesta al día en arritmias (VIII). Síncope. Rev Esp Cardiol. 2012; 65(8): 755- 765.
- Deharo JC, Guieu R, Mechulan A, Peyrouse E, Klipson N, Gerolami V et al. Syncope without prodromes in patients with normal heart and normal electrocardiogram. J Am Coll Cardiol 2013; 62(12): 1075-80.
- Brignole M, Hamdan M. New concepts in assessment of syncope. J Am Coll Cardiol 2012; 59(18): 1583-91.
- Ruwals M, Hansen ML, Lamberts M, Hansen CM, Vinther M, Køber L et al. Prognosis among healthy individuals discharged with a primary diagnosis of syncope. J Am Coll Cardiol 2013; 61(3): 325-32.
- Sheldon R. Syncope diagnostic scores. Progress in Cardiovascular diseases. 2013; 55: 390-395.
- Rosario S, Schwarz ER, Ware DL, Vitarelli A. Syncope in adults: Systematic review and proposal of a diagnostic and therapeutic algorithm. Int J Cardiol. 2013;162(3): 149-157.
- Rodríguez-Entem F, González-Enriquez S, Olalla-Antolín JJ, Cobo-Belaustegui M, Expósito-García V, Llano-Cardenal M et al. Manejo del síncope en el servicio de urgencias sin ingreso hospitalario: utilidad de un protocolo coordinado con la unidad de arritmias. Rev Esp Cardiol. 2008; 61(1):22-8.
- Romme JJ, van Dijk N, Boer KR, Bossuyt PM, Wieling W, Reitsma JB et al. Diagnosing vasovagal syncope based on quantitative history-taking: validation of the Calgary Syncope Symptom Score. Eur Heart J. 2009; 30(23): 2888-2896.
- Brignole M, Alboni P, Benditt DG, Bergfeldt L, Blanc JJ, Bloch Thomsen PE. Guidelines on management of syncope, update 2004. Europace 2004; 6(6): 467-537.
- Shen WK, Sheldon RS, Benditt DG, Cohen MI, Forman DE, Goldberger ZD et al. 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the evaluation and management of patients with syncope. A

Report American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2017; 136(5):e60-e122.